武汉养老机构精准匹配小程序 V1.1 页面级 PRD

调查问卷、机构资料与匹配逻辑扩展修订版 · 2026-09-04

本次修订说明

本版以原《V1 页面级 PRD》为基础，重点吸收新增的养老院资料需求，并按“问老人需要什么、机构资料记录能提供什么、推荐系统负责匹配”的原则更新。

修订范围	主要变化
健康问卷	新增咀嚼能力、吞咽情况；与鼻饲需求严格分离
养老偏好	新增房型、膳食、活动偏好；重构“最关注 3 项”
预算	新增高照护需求+较低预算的友好提醒逻辑
机构资料	扩充护理团队、医疗、日常检测、房间设施、膳食、活动、交通、医院距离、收费拆分
推荐逻辑	护理安全优先，其后生活适配、家庭偏好、费用；不展示伪精确百分比
数据真实性	未知不等于不支持；没有真实 VR/价格/人员数字时保持未知或请咨询

未在本次修订中点名调整的页面目标、登录授权、顾问、预约、隐私等原则继续沿用原 V1。

---

1. 文档目标

本 PRD 用于指导小程序 V1 的

- 产品原型设计

- UI/UX 设计
- 微信小程序前端开发
- 后端接口设计
- 数据库设计
- 推荐逻辑开发
- 后续机构资料录入与运营

V1 重点不是建设一个“大型养老机构平台”，而是完成一条完整且可转化的核心业务链路：

填写老人问卷 → 建立老人画像 → 推荐武汉合作养老机构 → 查看机构详情与 VR → 咨询养老顾问 → 预约看院

---

2. 产品基本定位

2.1 产品定义

一款面向武汉本地老人家庭的养老机构精准匹配小程序。用户通过结构化评估填写老人的基本情况、身体健康、日常生活能力、认知状态、特殊护理需求、进食与吞咽情况、养老偏好、预算与入住计划，系统形成可解释的老人养老需求画像，并从当前合作的约 7-8 家武汉中高端养老机构中进行匹配推荐。

老人侧评估重点

- 基本情况
- 身体健康与近期风险
- 咀嚼能力与吞咽情况
- 日常生活能力（ADL）
- 认知状态与特殊护理需求
- 养老偏好（机构类型、房型、膳食、活动与关注项）
- 预算与入住计划

机构侧信息重点

- 详细资料与人工核验状态
- 护理接收能力与特殊护理能力
- 护理团队与医护配置
- 房型与适老设施
- 膳食与特殊饮食支持
- 医疗、康复与日常健康检测
- 室内外活动空间与活动内容
- 交通区位与大型医院距离
- 结构化收费与一次性费用

- 实景图片、真实 VR、资质与顾问服务

产品仍采用“精选机构池 + 精准推荐”，不建设海量机构搜索平台。

---

3. 当前业务边界

3.1 服务城市

V1

仅武汉市

暂不建设

- 全国城市切换
- 多城市机构运营体系
- 全国养老政策数据库

因此前台不需要突出“城市切换”。

3.2 机构数量

V1

约 7～8 家合作养老机构

特点

- 已由平台人工对接
- 以中高端机构为主
- 月费用大约 3500 元以上
- 机构数量有限
- 平台可以对机构信息进行人工核验

因此产品采用

精选机构池 + 精准推荐

而不是

海量机构搜索平台

---

4. 核心用户

4.1 主要使用者

老人子女、配偶及其他家庭照护决策者。

主要年龄预计集中在

35～65 岁

4.2 被服务对象

需要养老服务的老人。

4.3 平台服务人员

养老顾问 / 经纪人。

主要负责

- 解读老人画像
- 解读推荐结果
- 推荐适合的养老机构
- 回答机构问题
- 协调 VR 看院
- 协调实地看院
- 跟进入住情况

---

5. 产品设计原则

5.1 先评估，后选机构

产品默认主路径

先完成老人需求评估，再进入精准机构推荐。

机构仍然允许直接浏览，但首页必须明显突出：

> **开始评估**

5.2 少机构，重内容只有约 7～8 家机构时，不追求复杂搜索功能。

更应该重点做好

- 机构信息完整度
- 真实环境展示
- VR
- 收费透明
- 护理能力说明
- 与老人需求匹配原因

5.3 推荐结果必须可解释

禁止只显示

匹配度 92%

应该明确告诉用户

为什么推荐。

例如

- 支持半失能老人
- 有夜间护理
- 有康复服务
- 符合预算
- 支持认知症专区

5.4 人工顾问必须贯穿关键节点

重要决策场景都应该有

> **咨询养老顾问**

入口。

> **5.5 VR 是机构详情页核心能力**

> **VR 不是附属功能。**

应作为

机构环境可信度展示的重要内容。

---

6. V1 整体页面结构

建议底部使用 3 个 Tab

1. 首页

2. 养老顾问

3. 我的

整体页面

首页

|

├── 评估说明

|

├── 老人基本情况

├── 健康情况

├── 日常生活能力

├── 认知与特殊照护

├── 养老需求与偏好

├── 预算与入住计划

├── 信息确认

└── 评估结果

└── 推荐机构

合作机构列表

└── 机构详情

├── 基础信息

├── 匹配原因

├── VR看院

├── 实景图片

├── 护理服务

├── 医疗能力

├── 房型

├── 收费

├── 资质

└── 评价

养老顾问

├── 顾问主页

├── 顾问详情

└── 咨询/联系

预约

├── **预约看院**

└── **预约成功**

我的

├── 老人档案

├── 我的评估

├── 我的推荐

├── 我的收藏

├── **我的预约**

└── 设置

7. 页面 01：首页

页面目标

完成三件事

1. 让用户理解产品用途

2. 引导用户开始老人需求评估

3. 建立平台和合作机构的可信度

页面结构

模块 A：顶部品牌区

内容

- 小程序 Logo
- 小程序名称
- 武汉本地服务说明

例如

武汉养老机构精准匹配

不需要城市选择器。

模块 B：Hero 主视觉

主标题

先了解老人情况，再找到更合适的养老机构

副标题

根据身体情况、照护需求、生活偏好和预算，从武汉合作养老机构中为您精准筛选。

主按钮

开始养老需求评估

次按钮

查看合作机构

按钮行为

点击

开始养老需求评估

→ 页面 02「评估说明页」

点击

查看合作机构

→ 页面 11「合作机构列表页」

模块 C：平台核心优势

使用 4 个简洁图标展示

先评估再推荐

根据老人实际情况筛选。

武汉本地机构

合作机构均位于武汉。

VR 在线看院

足不出户查看真实机构空间。

顾问协助

帮助理解机构区别并安排看院。

模块 D：快速养老需求入口

可设置

- 医养结合
- 失能护理
- 认知症照护
- 康复养老
- 活力养老

点击后

→ 合作机构列表

并自动带入对应标签。

模块 E：精选合作机构

展示 3 家，左右滑动。

机构卡字段

- 机构封面
- 机构名称
- 区域
- 机构类型
- 参考月费
- 2～3 个特色标签
- VR 标签

示例

XX颐养中心

洪山区

医养结合 · 康复护理

¥4800～7600/月

VR看院

操作

- 点击卡片 → 机构详情
- 点击 VR → VR 页面

模块 F：养老评估引导

标题

不知道该怎么选?

说明

回答几个关于老人身体和生活情况的问题，我们可以先帮您判断适合什么类型的养老机构。

按钮

3～5 分钟完成评估

模块 G：养老顾问入口

标题

有些问题，和养老顾问聊一聊更清楚

说明

- 帮您理解护理等级
- 对比不同机构
- 解读费用
- 协调看院

按钮

咨询养老顾问

→ 顾问主页

8. 页面 02：评估说明页

页面目标

降低用户填写问卷的心理压力。

页面内容

标题

全面了解老人情况，推荐才更准确

说明

我们会从身体健康、生活自理能力、认知状态、养老需求和预算等方面了解老人情况。

评估内容

展示 5 个步骤概览

1. 基本情况

2. 身体与自理能力

3. 认知与照护需求

4. 养老偏好

5. 预算与入住计划

提示

- 预计耗时：3～5 分钟
- 不清楚的问题可选择“暂不确定”
- 信息仅用于养老需求评估和机构推荐

页面底部

主按钮

开始评估

→ 页面 03

9. 页面 03：老人基本情况

页面目标

建立老人基础档案。

顶部

第1步/共6步

进度条

约 16%

字段 1：老人与您的关系

单选

- 父亲
- 母亲
- 祖父
- 祖母
- 外祖父
- 外祖母
- 配偶
- 本人
- 其他

必填。

字段 2：老人姓名

输入框。

说明

仅用于家庭档案识别。

可以选填。

字段 3：性别

- 男
- 女

必填。

字段 4：年龄

数字输入或滚轮选择。

建议

50～110。

必填。

字段 5：目前居住状态

单选

- 独居
- 与配偶同住
- 与子女同住
- 与其他亲属同住
- 当前住院
- 已入住养老机构
- 其他

字段 6：主要照护者

单选

- 配偶
- 子女
- 保姆
- 护工
- 社区照护
- 暂无固定照护者
- 其他

字段 7：是否有入住养老机构经历

- 有
- 没有

若选择「有」

展开

离开上一家机构的主要原因

多选

- 护理不理想
- 服务态度问题
- 收费较高
- 距离太远
- 医疗能力不足
- 环境不满意
- 饮食不满意
- 老人不适应
- 其他

底部操作

左

保存并退出

右

下一步

→ 页面 04

10. 页面 04：健康情况

> 页面目标：了解老人的基础疾病、近期健康风险、康复需求，以及影响养老机构膳食与进食照护的咀嚼/吞咽情况。

第2步/共6步

字段 1：目前是否存在以下疾病（多选）

- 高血压
- 糖尿病
- 冠心病
- 脑卒中后遗症
- 帕金森
- 阿尔茨海默症
- 其他认知障碍
- 慢性呼吸疾病
- 骨关节疾病
- 肿瘤
- 其他慢性疾病
- 暂无明显慢性疾病
- 暂不清楚

互斥：选择“暂无明显慢性疾病”或“暂不清楚”时，不与其他具体疾病并存。

字段 2：近期是否发生以下情况（多选）

- 近半年发生过跌倒
- 近半年发生过骨折
- 近半年频繁住院
- 近期刚出院
- 术后恢复中
- 长期卧床
- 存在压疮
- 以上均无
- 暂不清楚

字段 3：是否有康复需求（单选）

- 明确需要
- 可能需要
- 不需要
- 不确定

字段 4：老人目前的咀嚼情况如何（单选，新增）

- 正常咀嚼
- 更适合软食、易咀嚼食物
- 咀嚼能力较差，需要对食物做特殊处理
- 暂不确定

字段 5：老人目前的吞咽情况如何（单选，新增）

- 正常
- 偶尔吞咽不顺或容易呛咳
- 明显吞咽困难
- 暂不确定

业务边界
咀嚼困难或吞咽困难只表示饮食形式/进食照护可能需要进一步确认，不自动等于鼻饲需求。只有“鼻饲护理”被明确选择时，才形成对应的特殊护理需求。

上一步　　下一步 → 页面 05

11. 页面 05：日常生活能力

> 页面目标：通过具体生活场景判断老人照护强度，不让家属自行理解专业“失能等级”。

第3步/共6步

项目	选项
进食能力	完全独立 / 少量协助 / 需要喂饭 / 鼻饲或其他特殊进食方式
行走能力	独立行走 / 助行器 / 轮椅 / 基本无法下床
如厕能力	独立 / 偶尔协助 / 经常失禁 / 完全照护 / 导尿或造瘘
洗澡能力	自主 / 部分协助 / 完全协助
穿衣能力	自主 / 部分协助 / 完全协助
床椅转移	自主 / 少量帮助 / 需要搀扶 / 完全依赖
上下楼	独立 / 需要帮助 / 无法完成 / 当前无楼梯场景

后台结果

根据冻结的 ADL 规则形成“自理 / 轻度照护 / 半失能 / 失能 / 重度失能”画像标签。问卷阶段不要求用户自行判断等级。

进食字段解释
ADL 的“进食能力”回答“能否自主完成进食”；健康页新增的“咀嚼/吞咽”回答“吃什么形式、吞咽是否顺畅”。“特殊进食方式”是需要确认的照护线索，不自动推导为鼻饲。

上一步　　下一步 → 页面 06

12. 页面 06：认知与特殊照护

> 页面目标：判断老人是否存在认知风险，以及是否有需要机构明确支持的特殊护理需求。

第4步/共6步

模块 A：认知与精神状态（多选）

- 记忆力明显下降
- 经常重复询问相同问题
- 容易迷路
- 有走失风险
- 昼夜作息混乱
- 情绪波动明显
- 容易躁动
- 有攻击行为
- 已确诊认知症
- 无以上情况
- 暂不确定

模块 B：特殊护理需求（多选）

- 需要 24 小时照护
- 需要一对一护工
- 需要夜间重点照护
- 需要认知症专区
- 需要康复训练
- 鼻饲护理
- 导尿护理
- 压疮护理
- 失禁护理
- 其他
- 暂不确定

新增澄清逻辑
若健康页出现“明显吞咽困难”，但未明确选择“鼻饲护理”，画像应显示“吞咽情况需进一步确认”，不得自动形成鼻饲硬条件；“导尿/造瘘”同样不自动等于“导尿护理”需求。

上一步　　下一步 → 页面 07

13. 页面 07：养老需求与偏好

> 页面目标：了解家庭主观偏好，用于护理安全条件满足后的生活适配、偏好排序和推荐理由解释。

第5步/共6步

字段 1：更希望选择哪类养老方式（单选）

选项	人话解释
活力型养老	适合生活基本自理、重视生活品质的老人
医养结合	更重视医疗、护理与慢病管理
失能护理	适合半失能、失能老人
认知症照护	适合认知障碍老人
康复养老	适合术后、慢病或功能恢复老人
不确定	让系统根据老人情况判断

字段 2：希望老人入住什么房型（单选，新增）

- 不限制
- 单人间
- 双人间
- 三人及以上

房型属于生活偏好，不作为护理安全硬条件。

字段 3：对日常膳食安排有要求吗（单选，新增）

- 不特别要求
- 三餐
- 三餐一点
- 三餐两点

“易咀嚼/特殊处理饮食”由健康页咀嚼、吞咽情况形成适配提示，不要求用户在偏好页重复选择。

字段 4：老人平时是否重视活动和社交（单选，新增）

- 不特别在意
- 比较在意室内活动

- 比较在意户外活动
- 室内外活动都比较重要

字段 5：选择机构时最关注什么（最多 3 项，重构）

- 护理能力
- 护理人员质量
- 医疗条件
- 康复条件
- 膳食质量
- 居住环境
- 房间设施
- 活动空间
- 交通便利
- 靠近大型医院
- 价格预算
- 地理位置

删除过于笼统或与硬护理重复的“整体品质、认知症照护能力”等表述；认知症接收、鼻饲、导尿等明确护理需求由前面问卷形成硬条件，不靠主观“关注项”决定。

字段 6：希望所在区域

- 不限制
- 仅展示当前已核验合作机构实际存在的区域

区域候选由机构数据动态生成，不维护武汉全量行政区作为静态问卷选项。

上一步　　下一步 → 页面 08

14. 页面 08：预算与入住计划

> 页面目标：判断家庭支付能力和入住意向，同时在高照护需求与较低预算组合下进行友好提醒。

第6步/共6步

字段 1：预计每月可以接受的费用（单选）

- 3500-5000 元
- 5000-8000 元
- 8000-12000 元
- 12000-15000 元
- 15000 元以上
- 暂不确定

字段 2：对押金或一次性费用的接受程度

- 可以接受
- 视具体金额而定
- 不希望存在较高一次性费用
- 不清楚

字段 3：预计入住时间

- 希望尽快入住
- 1 个月以内
- 1-3 个月
- 3 个月以后
- 目前只是提前了解

字段 4：是否希望养老顾问后续协助

- 希望顾问联系我
- 先看推荐结果

新增提醒逻辑
当老人画像显示失能/重度失能，或明确存在一对一、鼻饲、压疮、24 小时照护等高强度照护需求，同时预算较低时，可提示“实际费用可能受护理等级、特殊护理和房型影响，建议预留预算空间”。提醒不阻止继续，也不得凭空给出武汉市场最低价。

本页仍不立即索取手机号；手机号仅在用户实际预约或明确要求顾问联系时授权获取。

上一步　　查看老人需求画像 → 页面 09

15. 页面 09：老人画像确认

> 页面目标：让用户确认系统是否正确理解老人，并在进入推荐前建立“被理解”的感觉。

建议展示模块

- 老人基本标签：关系、年龄、照护等级、行动方式
- 健康状态：主要疾病、近期风险、康复需求
- 进食与饮食：咀嚼情况、吞咽情况、需要确认的特殊进食线索
- 日常照护：进食、行动、如厕、洗澡、转移等关键能力
- 认知与特殊照护：认知风险、走失风险、明确特殊护理需求
- 养老偏好：倾向类型、房型、膳食、活动偏好、最关注 3 项、区域
- 预算与入住计划：预算区间、一次性费用接受度、入住时间

展示边界
咀嚼/吞咽异常不得直接显示为“鼻饲护理”；“特殊进食方式”“导尿/造瘘”等线索若未形成明确特殊护理需求，应显示为“需要进一步确认”。

每个模块提供“修改”入口，返回对应问卷步骤；底部主按钮：生成机构推荐。

16. 页面 10：评估结果与机构推荐

> 页面目标：先解释老人当前需要什么，再从精选合作机构中给出 1-3 家可解释的候选机构及差异。

模块 A：评估结果

展示当前最重要的照护与生活适配重点，例如照护等级、轮椅/卧床、康复、夜间照护、进食与吞咽提醒等。不得把未确认线索写成确定医学或护理结论。

模块 B：推荐原因

推荐理由来自结构化老人画像与已核验机构字段，例如“可接收当前照护等级”“支持轮椅”“提供康复训练”“参考费用处于预算区间”。

模块 C：选择机构时建议重点确认

- 护理员配置、持证与经验
- 夜间巡查与护士响应
- 膳食形式及特殊饮食支持
- 康复服务内容与是否额外收费
- 无障碍环境与房间呼叫设备
- 医疗急救能力与大型医院距离

模块 D：推荐机构

优先展示 1-3 家，不强行凑满 3 家。护理硬条件存在明确冲突时不得因价格、区域或环境偏好而“加分救回”。

状态	用户侧表达
确认匹配	关键护理需求已找到可确认匹配的候选
偏好有差异	护理条件满足，但预算/区域/类型等存在差异
需机构评估	关键护理能力需要机构结合老人具体情况进一步评估
资料待核验	不作为推荐卡，说明部分机构相关能力尚待核验

不展示伪精确“92% 匹配度”。核心仍是具体推荐理由、主要差异与需要确认的事项。

17. 页面 11：合作机构列表

页面目标

展示所有约 7～8 家合作机构。

顶部

标题

武汉合作养老机构

说明

以下均为当前平台合作机构。

如果用户已经完成评估

显示

已根据「父亲」的养老需求优先排序。

轻量筛选

只保留

区域

类型

- 医养结合
- 失能护理
- 认知症
- 康复养老
- 活力养老

价格

- 3500～5000
- 5000～8000
- 8000～12000
- 12000+

服务能力

- 认知症照护
- 康复

- 医疗支持
- 24小时护理

排序

- 为我推荐
- 综合
- 价格较低
- 距离较近

机构卡字段

- 图片
- 名称
- 区域
- 类型
- 月费
- 核心服务
- VR
- 推荐原因

18. 页面 12：机构详情页

页面目标

完成

> **了解 → 信任 → 比较 → VR → 咨询 → 预约**

是整个产品最重要的转化页面。

19. 机构详情顶部区域

大图区域

展示

- 机构封面
- 图片数量
- VR 入口

VR 入口必须明显

VR 沉浸式看院

基础信息

机构名称

标签

例如

- 医养结合
- 失能护理
- 康复
- 认知症

位置

武汉市洪山区……

参考费用

¥4800～8600 / 月

床位状态

- 有床位
- 少量床位
- 需咨询

20. 与老人需求匹配模块

用户完成评估后展示。

标题

为什么推荐给您

例如

- 支持轮椅老人
- 可接收半失能老人
- 提供康复训练
- 具备夜间护理
- 价格符合预算

如果有不匹配项

注意

该机构暂不提供一对一全天专护。

21. VR 空间预览模块

页面内卡片

大图

VR 缩略图。

标题

足不出户，先在线逛一遍

说明

在线查看房间、大厅、餐厅、康复区及公共活动空间。

主按钮

进入 VR 看院

22. 页面 13：VR 看院页

页面目标

让用户对真实空间形成更直观判断。

VR 页面结构

顶部

机构名称。

中间

VR 全景区域。

场景导航

可切换

- 机构外景
- 接待大厅
- 老人房间
- 卫生间
- 餐厅
- 康复区
- 活动区
- 户外花园

VR 热点

建议后期支持

点击床

护理床

点击卫生间

无障碍扶手

点击墙

紧急呼叫设备

底部固定按钮

咨询这个机构

预约实地参观

23. 机构详情：实景图集

> **即使已有 VR，也必须提供普通图片。**

分类

- 外景
- 大厅
- 房间
- 餐厅
- 卫生间
- 康复
- 活动区域
- 户外空间

点击进入图片浏览。

24. 机构详情：护理能力

> 标题：适合哪些老人。机构护理能力使用结构化、可核验的四态信息展示。

照护等级接收能力

老人类型	状态示例
自理	支持 / 需评估 / 暂不支持 / 资料待核验
轻度照护	支持 / 需评估 / 暂不支持 / 资料待核验
半失能	支持 / 需评估 / 暂不支持 / 资料待核验
失能	支持 / 需评估 / 暂不支持 / 资料待核验
重度失能	支持 / 需评估 / 暂不支持 / 资料待核验

重点护理与认知能力

- 轮椅支持
- 卧床支持
- 床椅转移支持
- 认知症接收
- 走失风险支持
- 认知症专区
- 24 小时照护
- 一对一护工
- 夜间照护
- 康复训练
- 鼻饲护理
- 导尿护理
- 压疮护理
- 失禁护理

“资料待核验”不等于“暂不支持”；机构类型标签也不能自动推导具体护理能力。

25. 机构详情：日常护理标准

展示日常护理标准，优先使用可核验事实：

- 起居与晨晚间照护
- 洗澡与个人卫生
- 翻身与压疮预防
- 喂饭与进食协助
- 如厕与失禁护理
- 夜间巡查
- 陪诊与紧急处理
- 护理员响应机制

护理团队补充字段（新增）

- 护理员人数
- 持证情况
- 从业经验
- 人员结构（仅在真实可核验时展示）
- 护理员与老人配置比例
- 护士响应时间

人员数量、比例、经验、响应时间均需真实来源；没有明确数字时显示“暂未提供相关资料/请咨询”，不虚构。

26. 机构详情：医疗与康复

医疗配置

- 是否有医生及医生数量（有真实数据再显示）
- 是否有护士及护士数量
- 是否设护士站/医务室
- 是否有社区卫生服务中心协作
- 是否有自有医院或合作医院
- 是否支持 24 小时医疗值班/值守
- 是否支持紧急送医
- 距离大型/三甲医院的可核验距离

日常健康检测（新增）

- 血压
- 血氧
- 按需血糖
- 检测频率：每日/每周/按需

康复

- 康复治疗师
- 康复理疗室/康复室
- 术后康复
- 肢体功能训练
- 认知训练
- 康复训练服务能力

“有康复室”不自动等于“康复训练能力已核验支持”；医疗设施、人员、服务能力分开记录。

27. 机构详情：人员配置

人员配置建议展示：

- 医生
- 护士
- 护理员
- 康复师
- 营养师
- 社工

新增可核验信息

- 医生/护士数量
- 护理员数量
- 护理员持证比例或持证情况
- 护理员从业年限/经验结构
- 医护/护理配置比例
- 24 小时值班人员情况
- 护士/护理响应时间

“年龄段”等人员结构信息只能作为透明度展示，不作为推荐排序的主观优劣分值；所有数字必须可核验。

28. 机构详情：房型

每种房型单独卡片。支持：单人间、双人间、三人及以上等真实存在的房型。

基础字段

- 图片
- 面积
- 床型
- 独立卫生间
- 空调
- 衣柜
- 电视
- 阳台
- 无障碍设施
- 参考房费

新增房间/适老设备字段

- 智能呼叫系统
- 电动窗帘
- 冰箱/小冰箱
- 适老化床边桌或折叠桌板
- 轮椅等辅助器具提供情况
- 智能音箱/收音机等生活设备
- 放大镜等适老辅助用品
- 书画/文房用品等个性化配置（有真实配置再展示）

不要求所有机构、所有房型字段齐全；缺失保持“暂未提供”，不能为了页面完整自动补“有”。

29. 机构详情：收费

> 收费必须结构化展示，突出“参考费用”而非承诺总价。

收费组成

- 床位费
- 餐食费
- 护理费
- 管理费（如真实存在）
- 特殊护理费
- 押金
- 其他一次性费用

参考总费用

支持“区间价”或“起步价”，例如 ¥5200-7800/月、¥5200 起/月；未知费用显示“暂未提供”，禁止用 ¥0 表示未知。

说明
最终费用会根据老人护理等级、房型、膳食安排及特殊护理服务确定。页面可说明费用构成，但不得把“起步价”当作最终总价。

30. 机构详情：资质

展示

- 营业执照
- 民政备案
- 养老机构评级
- 医保相关资格
- 医疗相关资质
- 合作医院
- 其他真实认证

点击

查看图片或详情。

31. 机构详情：评价

评分维度

- 护理态度
- 护理专业度
- 环境
- 餐饮
- 收费透明
- 医疗服务

单条评价

展示

- 匿名昵称
- 已入住家属认证
- 入住时长
- 评分
- 内容
- 图片
- 日期

32. 机构详情底部固定栏

固定

收藏

咨询顾问

预约看院

其中

预约看院

作为最强 CTA。

33. 页面 14：养老顾问主页

页面目标

承接用户不确定、不理解、需要线下服务的情况。

顶部文案

有些养老选择，和专业顾问聊一聊更省心

说明

顾问可以根据老人画像帮助您理解不同机构之间的差异，并协助预约 VR 或实地看院。

服务内容

- 解读老人画像
- 推荐合作机构
- 分析机构区别
- 解读收费
- 安排看院
- 跟进入住

34. 顾问卡片

字段

- 头像
- 姓名
- 养老顾问
- 服务区域：武汉
- 从业年限
- 已服务家庭数
- 个人介绍

前提

数据真实。

服务承诺

可展示

- 免费咨询
- 不向家属收取中介费
- 根据老人情况推荐
- 不强制选择机构

具体承诺需与真实业务模式一致。

操作

在线咨询

电话联系

请顾问帮我推荐

35. 页面 15：顾问详情

内容

头像

姓名

从业经验

擅长方向

例如

- 失能养老
- 医养结合
- 认知症
- 高品质养老

服务区域

武汉。

服务说明

已协助家庭数量

如果有数据。

底部按钮

微信咨询

电话咨询

帮我安排看院

36. 页面 16：预约看院

页面目标

将线上兴趣转化为真实线索。

顶部机构卡

显示

- 机构图片
- 机构名称
- 地址

字段 1：选择老人

如果已有老人档案

父亲 · 78岁

支持

新增老人

字段 2：预约日期

日历。

字段 3：希望时间

- 上午
- 下午
- 由顾问协调

字段 4：参观人数

- 1人
- 2人
- 3人
- 4人及以上

字段 5：是否需要接送

机构支持时显示

- 需要

- 不需要
- 先咨询

字段 6：联系人

姓名。

字段 7：手机号

微信手机号授权。

必填。

字段 8：备注

例如

老人目前住院，希望重点了解康复问题。

底部

提交预约

37. 页面 17：预约成功

标题

预约申请已提交

说明

养老顾问会进一步确认机构的接待时间，并与您联系。

展示

机构

XX养老中心

日期

2026-XX-XX

时间

下午

人数

2人

操作

联系养老顾问

查看我的预约

返回首页

38. 页面 18：我的

顶部

微信头像。

昵称。

老人档案卡

例如

父亲 · 78岁

标签

半失能 · 医养结合需求

操作

查看档案

主要功能

我的评估

我的推荐

我的收藏

我的预约

我的顾问

其他

- 联系客服
- 意见反馈
- 用户协议
- 隐私政策
- 授权管理

39. 页面 19：老人档案

支持一个用户管理多个老人。

例如

父亲

78岁

母亲

74岁

老人详情

展示

- 基本信息
- 健康情况
- 自理能力
- 认知
- 特殊护理
- 养老偏好
- 预算
- 最近评估时间

操作

重新评估

编辑档案

不要直接覆盖旧评估结果。

每次重新评估生成新的

Assessment。

40. 页面 20：我的评估

列表

父亲养老需求评估

日期

2026-XX-XX

结果

建议优先考虑医养结合型机构

操作

查看结果

重新评估

41. 页面 21：我的推荐

展示

基于每一次评估生成的推荐方案。

例如

父亲 · 2026-08-XX

推荐

1. A机构

2. B机构

3. C机构

操作

查看推荐详情

42. 页面 22：我的收藏

机构列表。

操作

- 查看机构
- VR 看院
- 取消收藏
- 预约看院

43. 页面 23：我的预约

状态

- 待确认
- 已确认
- 已完成
- 已取消

预约卡

字段

- 机构名称
- 日期
- 时间
- 老人
- 顾问
- 状态

操作

按状态显示

联系顾问

查看机构

取消预约

44. 关键空状态

所有页面必须设计空状态。

无老人档案

还没有建立老人档案

完成一次养老需求评估后，档案会自动生成。

按钮

开始评估

无评估

还没有养老需求评估

按钮

开始第一次评估

无收藏

还没有收藏机构

按钮

查看合作机构

无预约

暂时没有看院预约

按钮

看看推荐机构

45. 无完全匹配机构状态

> 无完全匹配时，不以空列表或强行补卡处理，而是解释“为什么没有完全匹配”以及还能做什么。

情况	处理
护理硬条件全部满足，但预算/区域/机构类型等偏好有差异	展示 1-3 家接近结果，并逐项说明差异
关键护理能力为“需评估”	单独展示“需要机构进一步评估的候选”，不能写成已支持
关键护理能力资料待核验	不作为推荐卡；说明平台资料尚不足
明确关键护理能力暂不支持	排除，不为凑数量放宽安全条件

操作：调整需求 / 让顾问帮我确认 / 查看全部合作机构（同源数据接入后）。

46. 登录与授权

浏览阶段

用户可以匿名

- 看首页
- 看机构
- 看 VR
- 看基本资料

以下场景要求登录

- 保存评估
- 保存老人档案
- 收藏
- 预约
- 联系顾问
- 查看历史记录

使用

微信快捷登录

47. 手机号授权

不要登录时强制获取。

仅在

- 预约
- 顾问需要联系

时获取。

48. 健康信息隐私

问卷提交前应明确提示

老人健康与照护信息仅用于养老需求评估、机构匹配与服务对接。

用户确认后提交。

49. 身份证信息

V1 不建议在评估问卷中填写身份证号码。

当前业务并不需要。

未来如果增加

- 长护险
- 补贴
- 正式入住办理

再在对应场景单独授权采集。

50. 推荐系统 V1 逻辑原则

V1 继续采用确定性、可解释的规则匹配，不使用大模型做核心推荐。推荐逻辑按层处理，不能把护理安全与偏好分数混为一个总分。

第一层：护理安全（硬条件）

- 照护等级接收
- 轮椅/卧床/转移支持
- 认知症接收与走失风险支持
- 明确特殊护理：24 小时、一对一、夜护、认知症专区、康复训练、鼻饲、导尿、压疮、失禁

明确“暂不支持”的关键能力直接形成冲突；“需评估”与“资料待核验”必须与“支持”分开处理。

第二层：生活适配

- 咀嚼/吞咽与膳食形式适配
- 房型偏好
- 康复需求
- 居住与适老设施

第三层：家庭偏好

- 护理人员质量
- 医疗配置
- 康复条件
- 膳食质量
- 居住环境
- 房间设施
- 活动空间
- 交通便利
- 靠近大型医院
- 机构类型与区域

第四层：费用适配

- 参考月费与预算区间
- 床位/餐食/护理/特殊护理费用构成
- 押金与一次性费用接受度

预算、区域等软条件不能抵消护理硬冲突；结果不展示伪精确匹配百分比。

51. 推荐结果解释

最终结果必须给出可理解的“为什么推荐”和“哪里需要确认”。

推荐原因示例

✓ 可接收当前照护等级老人
✓ 支持轮椅与床椅转移
✓ 提供康复训练
✓ 膳食可提供易咀嚼选择（已核验时）
✓ 参考费用处于预算范围

差异/待确认示例

△ 鼻饲护理需要机构结合老人具体情况进一步评估
△ 当前床位需咨询
△ 参考起步价高于家庭预算范围

禁止只返回“A 92% / B 86% / C 81%”。

52. 机构后台资料字段建议

为了支撑新版问卷、机构详情和推荐，每家机构资料建议按以下 8 类录入。所有匹配关键字段应有来源和核验状态；缺失保持 unknown，不使用 false/0 代替。

1. 基础与资质

- 名称、地址、区域代码、经纬度（有真实值再录）
- 成立时间、床位数、机构类型
- 营业资质、民政备案、评级、医疗相关资质及有效期

2. 护理能力与团队

- 自理、轻度照护、半失能、失能、重度失能接收能力
- 轮椅、卧床、转移支持
- 护理员人数、持证情况、从业经验、护理配置比例、响应时间
- 24 小时照护、一对一、夜间护理、认知症专区、康复训练、鼻饲、导尿、压疮、失禁护理

3. 医疗与康复

- 医生/护士及数量、护士站/医务室
- 社区卫生服务中心、自有医院/合作医院
- 24 小时医疗值守、紧急送医
- 血压/血氧/按需血糖检测及频率
- 康复师、康复室、术后/肢体/认知训练

4. 房间与适老设施

- 单人间、双人间、三人及以上房型
- 面积、床型、独卫、空调、衣柜、电视、阳台、无障碍
- 智能呼叫、电动窗帘、小冰箱、床边桌板、辅助器具与其他真实配置

5. 膳食

- 三餐 / 三餐一点 / 三餐两点
- 易咀嚼/软食支持
- 特殊处理饮食支持（需明确服务边界）
- 餐食费及是否随特殊饮食调整

6. 活动与空间

- 室内/室外活动空间
- 舞蹈/书法/美术手工/棋牌/综合活动

- 音乐疗愈、健身活动
- 楼层分布：公共活动区、活力区、照护区、认知症专区（真实存在再录）

7. 交通区位

- 地铁、公交、打车/车辆通达情况
- 距离大型/三甲医院的可核验距离

8. 收费、媒体与 VR

- 参考总月费：区间/起价
- 床位费、餐食费、护理费、特殊护理费、押金和一次性费用
- 实景图片分类
- 真实 VR 地址、封面、场景；无真实 VR 时保持空值

53. V1 核心数据对象

建议后端/领域层至少包含以下核心数据对象，并让新字段保持结构化而不是塞进自由文本 tags：

- User 用户
- Elder 老人
- Assessment / AssessmentAnswer 评估与答案
- ElderProfile 老人画像
- Institution 机构
- InstitutionCapability 机构护理能力
- InstitutionVerification / Evidence 字段级核验信息
- InstitutionStaffing 人员配置
- InstitutionMedical 医疗配置
- InstitutionRehabilitation 康复配置
- InstitutionMeal 膳食服务
- InstitutionActivity 活动与空间
- InstitutionTransport 交通区位
- InstitutionRoom 房型与设施
- InstitutionPrice / PriceComponent 参考费用与费用组成
- InstitutionMedia / InstitutionVR / InstitutionQualification
- Recommendation / RecommendationReason / RecommendationDifference
- Consultant 养老顾问
- Appointment 预约

老人侧与机构侧分别维护真实事实，推荐系统只负责匹配，不在页面层重新推导护理结论。

54. 页面间关键跳转关系

首页

↓

评估说明

↓

基本情况

↓

健康情况

↓

ADL

↓

认知与特殊护理

↓

养老偏好

↓

预算

↓

画像确认

↓

推荐结果

↓

机构详情

├──→ VR看院

├──→ 咨询顾问

└──→ 预约看院

↓

预约成功

55. V1 页面优先级

P0：必须完成

1. 首页

2. 评估说明

3. 基本信息

4. 健康情况

5. ADL

6. 认知与特殊护理

7. 养老需求

8. 预算

9. 画像确认

10. 推荐结果

11. 合作机构列表

12. 机构详情

13. VR

14. 顾问主页

15. 预约看院

16. 预约成功

17. 我的

18. 老人档案

19. 我的评估

20. 我的预约

P1：建议完成

- 收藏
- 我的推荐
- 真实评价
- 顾问详情
- 机构轻量筛选

P2：未来再做

暂不建议 V1 投入

- 全国城市
- 复杂地图
- 大量政策资讯
- 政策自动补贴测算
- AI 对话养老顾问
- 复杂机构横向比较
- 养老资讯门户
- 直播
- 社区
- 养老商城

56. V1 最终用户体验目标

用户不需要理解养老行业复杂术语。

整个过程应该让用户感觉自己只做了四件事

第一步

告诉平台老人现在是什么情况。

第二步

平台帮我判断应该找什么类型的养老机构。

第三步

从武汉这几家合作机构里告诉我哪几家比较合适，以及为什么。

第四步

通过图片和 VR 看环境，有问题问顾问，满意后预约去现场看。

57. V1 核心产品闭环

最终只需要把这一条链路做到非常顺

问卷

→ 老人画像

→ 精准推荐

→ 机构详情

→ VR看院

→ 顾问咨询

→ 实地预约

→ 成交入住

这就是当前阶段最重要的产品闭环。